

Caderno de questões comentadas

24 questões no estilo de banca cruzando os quatro temas da apostila: antimicrobianos, Portaria 344/98, interações/CYP450 e fármacos do SNC. Cada item traz **gabarito comentado** com a justificativa da correta e a armadilha das distratoras.

6 questões por bloco · clique em "ver gabarito" para testar-se antes

Como usar: responda primeiro sem olhar o gabarito; depois expanda o comentário. Na versão em PDF, os gabaritos já aparecem abertos para revisão corrida.

01 Antimicrobianos

1

MECANISMO DE AÇÃO

Paciente com infecção de corrente sanguínea por *S. aureus* resistente à meticilina (MRSA) recebe vancomicina. O mecanismo de ação desse fármaco é:

- A Inibição da transpeptidase por ligação às PBP
- B Ligação ao terminal D-alanil-D-alanina do precursor da parede, impedindo a transpeptidação
- C Inibição da subunidade ribossomal 30S
- D Inibição da DNA-girase
- E Desorganização da membrana de forma cálcio-dependente

Resposta: B

A vancomicina é um **glicopeptídeo** que se liga ao **D-Ala-D-Ala**, bloqueando a polimerização do peptidoglicano — por ser uma molécula grande, só age em Gram+.

Distratoras: A = β -lactâmicos; C = aminoglicosídeos/tetraciclinas; D = quinolonas; E = daptomicina. A resistência (VRE) troca o alvo para **D-Ala-D-Lac**.

2

ESPECTRO DE AÇÃO

Assinale o antimicrobiano que **NÃO** possui cobertura contra MRSA:

- A Vancomicina
- B Linezolida
- C Daptomicina
- D Ceftriaxona
- E Ceftarolina

Resposta: D

As cefalosporinas **clássicas** (como a ceftriaxona, 3ª geração) **não cobrem MRSA**. A exceção é a **5ª geração (ceftarolina)**, desenhada justamente para o MRSA.

Vancomicina, linezolida e daptomicina são opções consagradas para Gram+ resistentes.

3

APLICAÇÃO CLÍNICA

Apesar de ativa contra MRSA, a daptomicina **não** deve ser usada no tratamento de pneumonia porque:

- A Não tem ação contra Gram-positivos
- B É inativada pelo surfactante pulmonar
- C Não atinge concentração sérica adequada
- D Provoca pneumonite química
- E É antagonizada pelo oxigênio alveolar

Resposta: B

A daptomicina é **inativada pelo surfactante**, perdendo eficácia no pulmão — por isso é reservada a bacteremia/endocardite e pele. Monitorar **CPK** (miopatia).

4

FARMACOLOGIA

Sobre os aminoglicosídeos (ex.: gentamicina, ampicilina), é correto afirmar:

- A São bacteriostáticos de amplo espectro
- B São ativos contra anaeróbios estritos
- C São bactericidas concentração-dependentes, com risco de nefro e ototoxicidade
- D Atuam na subunidade ribossomal 50S
- E Não apresentam sinergia com β -lactâmicos

Resposta: C

Aminoglicosídeos atuam na **30S**, são **bactericidas concentração-dependentes** e têm como toxicidades clássicas a **nefro e a ototoxicidade**.

São **inativos em anaeróbios** (a captação depende de oxigênio) e fazem **sinergia** com β -lactâmicos (ex.: endocardite enterocócica).

5

RESISTÊNCIA BACTERIANA

A resistência do *S. aureus* à oxacilina (fenótipo MRSA) é mediada principalmente por:

- A Produção de penicilinase
- B Alteração da proteína ligadora de penicilina (PBP2a, gene *mecA*)
- C Bomba de efluxo
- D Produção de carbapenemase
- E Perda de porinas

Resposta: B

O MRSA expressa a **PBP2a** (gene *mecA*), de baixa afinidade pelos β -lactâmicos — por isso é resistente a praticamente todos eles, exceto a **ceftarolina**.

A penicilinase (A) explica a resistência à penicilina G, não o fenótipo meticilino-resistente.

Paciente em uso de sertralina inicia linezolida para infecção por VRE. O principal risco dessa associação é:

- A Síndrome serotoninérgica
- B Agranulocitose
- C Síndrome do homem vermelho
- D Crise hipertensiva por tiramina
- E Rabdomiólise

Resposta: A

A **linezolida** tem atividade **IMAO fraca**; associada a um ISRS (sertralina), pode desencadear **síndrome serotoninérgica** (alteração mental + hiperatividade autonômica + clônus).

A síndrome do homem vermelho (C) é da vancomicina por infusão rápida.

7

RECEITUÁRIO

Os medicamentos das listas A1, A2 (entorpecentes) e A3 (psicotrópicos) são dispensados mediante:

- A Receita de Controle Especial branca em 2 vias
- B Notificação de Receita "A", de cor amarela
- C Notificação de Receita "B", de cor azul
- D Receita médica comum, sem retenção
- E Notificação de Receita Especial branca

Resposta: B

Lista **A** → Notificação de Receita **A**marela, validade de 30 dias, até 30 dias de tratamento e 5 ampolas. É a única cuja numeração/talonário é fornecida pela vigilância sanitária.

8

ADENDO DE PROVA

Um comprimido de tramadol 50 mg pertence à lista A2. O receituário correto para a dispensação é:

- A Notificação de Receita A (amarela)
- B Notificação de Receita B (azul)
- C Receita de Controle Especial em 2 vias (branca)
- D Receita médica comum
- E Notificação de Receita Especial branca

Resposta: C

Adendo clássico: **codeína e tramadol até 100 mg** por unidade posológica migram para a **Receita de Controle Especial em 2 vias**, e não a NR-A. O mesmo vale para **oxicodona LC ≤ 40 mg** (lista A1).

9

QUANTIDADE

Carbamazepina (lista C1) é prescrita para epilepsia. A quantidade máxima de tratamento que pode constar na receita é:

- A 30 dias
- B 60 dias
- C Até 6 meses de tratamento
- D 90 dias
- E Quantidade ilimitada

Resposta: C

Adendo do Art. 59: **anticonvulsivantes e antiparkinsonianos** da lista C1 podem ser prescritos para **até 6 meses** de tratamento, sem necessidade de justificativa. As demais substâncias C1/C5 ficam limitadas a 60 dias.

10

CLASSIFICAÇÃO

As substâncias da lista D1 (precursoras de entorpecentes/psicotrópicos) exigem:

- A Notificação de Receita A amarela
- B Receita de Controle Especial em 2 vias
- C Receita médica comum, sem retenção
- D Notificação de Receita Especial branca
- E Autorização do Ministério da Justiça para cada dispensação

Resposta: C

A "pegadinha do sem retenção": **D1** é controlada, porém dispensada com **receita comum, sem retenção**. Já a **D2** (insumos químicos) fica sob o **Ministério da Justiça/Polícia Federal** (SIPROQUIM).

11

DISPENSAÇÃO

A talidomida (lista C3) caracteriza-se por:

- A** Dispensação por receita comum
- B** Notificação de Receita Especial, com dispensação exclusiva em farmácias do serviço público
- C** Notificação de Receita B azul
- D** Notificação de Receita A amarela
- E** Venda livre em drogarias

Resposta: B

Pelo histórico de teratogenicidade (focomelia), a **talidomida** usa **Notificação de Receita Especial** e tem **dispensação restrita ao serviço público** (RDC 11/2011 e RDC 735/2022), com termo de responsabilidade.

12

VALIDADE

Sobre a Notificação de Receita B (cor azul), assinale a alternativa correta:

- A** É de cor amarela e destina-se a entorpecentes
- B** Tem validade de 30 dias; a B1 permite até 60 dias e a B2 até 30 dias de tratamento
- C** É destinada a substâncias retinoicas
- D** Tem validade de 6 meses
- E** Dispensa retenção na farmácia

Resposta: B

A NR-B (azul) cobre **B1 (psicotrópicos)** e **B2 (anorexígenos)**, com validade de **30 dias**; o tempo de tratamento é de **60 dias na B1** e **30 dias na B2**. Não confunda validade da notificação com o tempo de tratamento.

03

Interações medicamentosas & CYP450

13

INDUÇÃO ENZIMÁTICA

Mulher em uso de contraceptivo oral combinado inicia rifampicina para tuberculose. A consequência farmacológica esperada é:

- A Toxicidade estrogênica por acúmulo do contraceptivo
- B Aumento do nível sérico de estrogênio
- C Falha contraceptiva por indução do CYP3A4
- D Síndrome serotoninérgica
- E Ausência de interação clinicamente relevante

Resposta: C

A **rifampicina é indutor potente** do CYP3A4 → acelera o metabolismo do contraceptivo → **queda do nível** → **falha contraceptiva**. Orientar método adicional. Indução = efeito **lento** (1-2 semanas).

14

PRÓ-FÁRMACO

Paciente coronariopata em uso de clopidogrel passa a usar omeprazol. O risco dessa associação é:

- A Aumento do efeito antiagregante do clopidogrel
- B Redução da ativação do clopidogrel por inibição do CYP2C19, diminuindo a antiagregação
- C Sangramento por potencialização do clopidogrel
- D Rabdomiólise
- E Hipercalemia

Resposta: B

O clopidogrel é **pró-fármaco** ativado pelo **CYP2C19**; o omeprazol **inibe** essa enzima → menos fármaco ativo → **perda de efeito** (a lógica invertida dos pró-fármacos). Preferir pantoprazol se necessário.

15

INTERAÇÃO ALIMENTAR

O consumo de suco de toranja (grapefruit) por paciente em uso de sinvastatina pode causar:

- A Redução da estatina por indução enzimática
- B Aumento da estatina por inibição do CYP3A4 intestinal, com risco de rabdomiólise
- C Nenhum efeito clínico
- D Antagonismo farmacodinâmico
- E Quelação e redução da absorção

Resposta: B

A toranja **inibe o CYP3A4 da parede intestinal** → ↑ biodisponibilidade da sinvastatina → risco de **miopatia/rabdomiólise**. O efeito dura até ~72 h (não basta espaçar horários).

16

EXCREÇÃO RENAL

Paciente bipolar em uso de lítio inicia hidroclorotiazida para hipertensão. O principal risco é:

- A Redução do nível de lítio e falha terapêutica
- B Intoxicação por lítio por redução da excreção renal
- C Síndrome serotoninérgica
- D Indução do metabolismo do lítio
- E Ausência de interação

Resposta: B

Tiazídicos, AINEs e IECA/BRA reduzem a excreção renal do lítio → **intoxicação** (janela estreita 0,6–1,2 mEq/L): tremor, ataxia, confusão. Monitorar litemia.

17

INDUÇÃO · TABAGISMO

Paciente esquizofrênico estável em uso de clozapina é internado e para de fumar abruptamente. Espera-se:

- A Queda do nível sérico de clozapina
- B Aumento do nível de clozapina e risco de toxicidade, pela perda da indução do CYP1A2
- C Nenhuma alteração de nível
- D Indução adicional do metabolismo
- E Síndrome de abstinência da clozapina

Resposta: B

A fumaça do cigarro **induz o CYP1A2**. Ao **cessar**, a enzima reduz e a **clozapina sobe** → toxicidade (sedação, convulsão). Aplica-se também a **teofilina e olanzapina**. Requer ajuste de dose.

18

INTERAÇÃO ALIMENTAR

Paciente em uso de tranilcipromina (IMAO) apresenta cefaleia intensa e PA 220×120 mmHg após jantar com queijos curados e vinho tinto. A causa é:

- A Síndrome serotoninérgica
- B Crise hipertensiva por tiramina
- C Efeito dissulfiram
- D Hipertensão essencial descompensada
- E Feocromocitoma

Resposta: B

O IMAO impede a degradação da **tiramina** dos alimentos fermentados → liberação maciça de noradrenalina → **crise hipertensiva** ("reação do queijo"). Por isso a dieta restrita é mandatória.

19

MECANISMO DE AÇÃO

O mecanismo de ação dos benzodiazepínicos consiste em:

- A Aumentar a duração de abertura do canal de cloro
- B Modular alostericamente o receptor GABA-A, aumentando a frequência de abertura do canal de cloro
- C Antagonizar o receptor GABA
- D Agonizar o receptor NMDA
- E Bloquear canais de sódio dependentes de voltagem

Resposta: B

Benzodiazepínicos **aumentam a frequência** de abertura do canal de Cl^- (GABA-A); os **barbitúricos aumentam a duração** — por isso são mais letais em overdose. Antídoto do BZD: **flumazenil**.

20

MONITORIZAÇÃO

A clozapina exige hemograma seriado pelo risco de:

- A Hepatotoxicidade
- B Agranulocitose
- C Síndrome metabólica
- D Discinesia tardia
- E Nefrotoxicidade

Resposta: B

O risco de **agranulocitose** impõe monitorização do hemograma. A clozapina é reservada à **esquizofrenia refratária** (também: miocardite, convulsão, sialorreia), mas reduz suicídio.

21

EFEITO ADVERSO

A discinesia tardia, associada ao uso prolongado de antipsicóticos típicos, decorre de:

- A Bloqueio agudo dos receptores D2
- B Hipersensibilidade (up-regulation) de receptores dopaminérgicos por bloqueio crônico
- C Excesso de acetilcolina estriatal
- D Bloqueio serotoninérgico
- E Excitotoxicidade glutamatérgica

Resposta: B

O bloqueio D2 **crônico** gera **hipersensibilidade** dos receptores → movimentos involuntários tardios, potencialmente **irreversíveis**. Já a distonia aguda (horas-dias) responde a anticolinérgico/biperideno.

22

ANTIPARKINSONIANO

A carbidopa é associada à levodopa com o objetivo de:

- A Aumentar a conversão de levodopa em dopamina no SNC
- B Inibir a dopa-descarboxilase periférica, elevando a levodopa que chega ao cérebro e reduzindo náuseas
- C Bloquear a enzima COMT
- D Inibir a MAO-B
- E Antagonizar receptores dopaminérgicos periféricos

Resposta: B

A carbidopa **não cruza a barreira hematoencefálica** e inibe a **dopa-descarboxilase periférica** → mais levodopa chega ao SNC e há menos náusea/efeitos periféricos. Atenção: **proteínas da dieta** competem na absorção da levodopa.

23

TOXICOLOGIA

A tríade clássica da intoxicação por opioides é composta por:

- A Midríase, taquicardia e hipertensão
- B Rebaixamento do nível de consciência, depressão respiratória e miose puntiforme
- C Convulsão, febre e rigidez muscular
- D Hipertermia, clônus e agitação
- E Bradicardia, hipotermia e rubor

Resposta: B

A tríade opioide → antídoto **naloxona**. A alternativa D descreve a **síndrome serotoninérgica** e a C remete à **síndrome neuroléptica maligna**. Lembrar: a combinação **opioide + benzodiazepínico** é a mais letal.

24

INTEGRATIVA · CYP · 344

Sobre o ácido valproico, assinale a alternativa correta:

- A É indutor enzimático potente do CYP450
- B É inibidor enzimático, eleva o nível de lamotrigina (risco de Stevens-Johnson) e é teratogênico
- C Não apresenta interação com outros anticonvulsivantes
- D É considerado seguro na gestação
- E É indicado exclusivamente para crises de ausência

Resposta: B

Ao contrário de fenitoína, carbamazepina e fenobarbital (indutores), o **valproato é inibidor** enzimático → **aumenta a lamotrigina** (titular devagar pelo risco de SJS). É **teratogênico** (espinha bífida) e tem amplo espectro (não só ausência). Pertence à lista **C1** da Portaria 344/98.

Caderno de questões de revisão para residência multiprofissional em farmácia · elaborado para fixação dos quatro temas da apostila. Questões autorais de estudo, em estilo de banca — não reproduzem prova específica. Confirme sempre condutas e doses na referência clínica e nos protocolos vigentes.